

Trzy poziomy — *RED, AMBER, GREEN*

MEED zastąpiło MARSIPAN. Klasyfikacja medyczna oparta na integracji BMI, tempa utraty wagi, parametrów krążeniowych i laboratoryjnych. Nie tylko BMI.

CZAS: 15 min — narzędzie kliniczne **REALIZACJA:** każda ocena pacjenta z AN; co 1-4 tyg.

ŹRÓDŁO: Royal College of Psychiatrists (2022, *Medical Emergencies in Eating Disorders*); Mehler & Andersen (2017, *Eating Disorders: A Guide to Medical Care*); MARSIPAN (2014, poprzednie wytyczne)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy poziomy ryzyka** MEED 2022: RED (wysokie, zagrażające życiu), AMBER (średnie), GREEN (niskie). W sekcji 02 — **siedem wskaźników**, które się uwzględnia (BMI to tylko jeden z nich). Sekcja 03 — **twoja ocena** + częstotliwość monitorowania. Sekcja 04 — implikacje kliniczne.

DLACZEGO TO DZIAŁA

MEED (*Medical Emergencies in Eating Disorders*, Royal College of Psychiatrists, 2022) — aktualne brytyjskie wytyczne zastępujące MARSIPAN. Ocena medycznego ryzyka oparta na *wielu parametrach jednocześnie*: BMI, tempo spadku wagi, tętno, ciśnienie, temperatura, elektrolity, EKG. **Czerwona strefa** = ryzyko zagrożenia życia → pilna hospitalizacja niezależnie od motywacji pacjenta. **BMI sam w sobie** jest niewystarczający — pacjent z atypową AN może być w czerwonej strefie przy „normalnym” BMI.

01 Trzy poziomy ryzyka MEED 2022

RED · WYSOKIE RYZYKO

Jeden z kryteriów wystarczy:

- BMI < 13 (dorośli) / < 70% mas. ocz. (młodzież)
- utrata > 1 kg/tydz. przez ≥ 2 tyg.
- tętno < 40/min
- ortostat. > 20 mmHg
- temp. < 35°C
- K < 3,0 mmol/l
- fosfor < 0,6 mmol/l
- zmiany EKG (QTc)

→ natychmiastowa hospitalizacja

AMBER · ŚREDNIE

Wymaga intensywnego monitorowania:

- BMI 13-15
 - utrata 0,5-1 kg/tydz.
 - tętno 40-50/min
 - inne nieprawidłowości laboratoryjne (bez wartości krytycznych)
- **ambulatoryjne intensywne**, ocena co 1-2 tyg.

GREEN · NISKIE

Stabilne parametry:

- BMI ≥ 15
 - stabilne tętno i ciśnienie
 - elektrolity w normie
 - EKG w normie
- **ambulatoryjne standardowe**, ocena co 4-12 tyg.

02 Siedem wskaźników MEED — pełny obraz

WSKAŹNIK	PRÓG ALARMOWY (RED)
1 · BMI	Dorośli < 13 (przybliżenie). Młodzież < 70% oczekiwanej masy lub < 5 percentyla. Sam BMI niewystarczający — zawsze w kontekście pozostałych wskaźników.
2 · Tempo utraty	> 1 kg/tydzień przez co najmniej 2 tygodnie. <i>Tempo</i> jest często bardziej predykcyjne dla powikłań niż bezwzględne BMI.
3 · Tętno (bradykardia)	< 40/min spoczynkowe. Niedożywienie obniża tętno spoczynkowe — przy ciężkim niedożywieniu serce traci masę mięśniową.
4 · Ciśnienie	SBP < 80 mmHg lub ortostazyzm (spadek > 20 mmHg przy zmianie pozycji). Ryzyko omdleń, urazów.
5 · Temperatura	< 35°C. Hipotermia z powodu utraty tkanki tłuszczowej i adaptacyjnego spadku metabolizmu.
6 · Elektrolity	Potas < 3,0 mmol/l (ryzyko arytmii). Fosfor < 0,6 mmol/l (zespół ponownego odżywiania). Magnez nisko (często pomijany).
7 · EKG	Wydłużone QTc (> 450 ms u mężczyzn, > 470 ms u kobiet) — ryzyko nagłej śmierci sercowej. Inne zmiany: niskie napięcie, zmiany ST-T.

03 Moja ocena MEED + częstotliwość monitorowania

WSKAŹNIKI SPEŁNIONE U MOJEGO PACJENTA

WSTĘPNA KLASYFIKACJA: RED / AMBER / GREEN

— które z 7; pamiętaj: jeden kryterium RED wystarczy do decyzji — + uzasadnienie; data oceny

CZĘSTOTLIWOŚĆ MONITOROWANIA

— RED: codziennie/co 2–3 dni; AMBER: co 1–2 tyg.; GREEN: co 4–12 tyg.

KOORDYNACJA Z LEKARZEM PROWADZĄCYM

— kto wykonuje pomiary, kto interpretuje, kto decyduje o hospitalizacji; ścieżka eskalacji

Klucz: MEED (Royal College of Psychiatrists, 2022) zastąpiło MARSIPAN i wprowadziło *holistyczne* spojrzenie na ryzyko medyczne w AN — *integrację* BMI, tempa utraty wagi, parametrów krążeniowych, badań laboratoryjnych. Sam BMI *nie* wystarcza. Mehler i Andersen (2017): „pacjenci z AN mogą wyglądać stabilnie i mieć zagrażające życiu zaburzenia”. Kluczowe: **jeden kryterium RED wystarczy** do natychmiastowej decyzji o hospitalizacji. Pacjent z BMI 17 ale tętnem 38/min i potasem 2,8 — RED. Pacjent z BMI 14 ale stabilnymi parametrami medycznymi — nadal poważny, ale niekoniecznie RED. Decyzja o hospitalizacji *powinna* opierać się na MEED, nie na ogólnej ocenie ani na samym BMI. **Częstotliwość monitorowania:** RED — codziennie lub co 2–3 dni; AMBER — co 1–2 tygodnie; GREEN — co 4–12 tygodni. Klinicysta psychoterapeuta nie wykonuje samodzielnie tych pomiarów — koordynuje z lekarzem prowadzącym i dietetykiem.

△ Pacjenci często minimalizują objawy somatyczne („nic mi nie jest, zawsze tak miałem”) — bradykardia i hipotensja są w głodzie adaptacjami, których pacjent nie odczuwa subiektywnie. Konsultacja medyczna i badania laboratoryjne nie są opcjonalne — są integralną częścią oceny każdej osoby z AN. Lekarz pierwszego kontaktu lub psychiatra może zlecić badania (morfologia, elektrolity, mocznik, kreatynina, funkcja wątroby, glukoza, EKG).